



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صفاء محمد صادق حسن
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : النزهه
رقم البطاقة : 26108150103189 رقم التليفون : 01150769303
العنوان : ----
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-08-1961 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صفاء محمد صادق حسين National ID: 26108150103189	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



صفاء
محمد صادق حسن
١١٥ ش عثمان بن عفان
النزهة - القاهرة



٢٦١.٨١٥.١.٣١٨٩

JU3013581

٢٠٢٣/٠١ ٢٦١.٨١٥.١.٣١٨٩
بدون عمل
مسلمة
أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٨



Patient Name	صفاء محمد صافي جين	Case No.	264259
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	26298
Registered Date	03/6/2026 09:19:38 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	25/6/2026 08:49:25 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	29/6/2026 12:18:22 PM	Pathology No.	1736/26

Pathology

Report

Clinical Data: Right breast axillary tail mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 03/06/2026, at 1:25 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey-white tissue cores, ranging in size between 0.4 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
 - Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
 - Ductal carcinoma in situ: Absent.
 - Microcalcification: Absent.
 - Necrosis: Minimal.
 - Angiolymphatic invasion: Absent.
 - Perineural invasion: Absent
 - Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

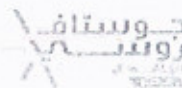
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
 - ER: Moderate nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 4/8).
 - PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).



غرفة رقم (4) - دور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misor El Qadima - Cairo, Egypt



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال - مصر. معمل الباثولوجي



Patient Name	صفاء محمد صادق جبين	Case No.	264259
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	20298
Registered Date	03/6/2026 09:19:38 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	25/6/2026 08:49:25 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	29/6/2026 12:18:22 PM	Pathology No.	1736/26

- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 25%.

Conclusion:

Right breast axillary tail mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 4/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 25%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim.

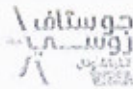


غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mir El Qasema - Cairo, Egypt

Patient Name	صفا محمد صبري حسن	Case No.	264259
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	20293
Registered Date	03/6/2026 09:19:38 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	25/6/2026 08:49:25 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	29/6/2026 12:18:22 PM	Pathology No.	1736/26



غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient's Name: Safaa Mohammed Sadiq Hassan
Date: 2026-05-13
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Right breast lesion measuring 37 x 21 mm for sono-mammography.
- Few bilateral scattered fine atelectatic bands.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

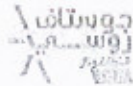
- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are seen fused at the midline (horse-shoe kidney) showing preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes. Right renal cortical cyst.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Spondylotic changes of the spine with minimal lytic anterolisthesis of L5 over S1 vertebra.

Opinion:

❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy



Patient's Name: Safaa Mohammed Sadiq Hassan
Date: 2026-05-13
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Right breast lesion measuring 37 x 21 mm for sono-mammography.
- Few bilateral scattered fine atelectatic bands.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are seen fused at the midline (horse-shoe kidney) showing preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes. Right renal cortical cyst.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulac or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Spondylotic changes of the spine with minimal lytic anterolisthesis of L5 over S1 vertebra.

Opinion:

❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy